Le fait du jour

SUD OUEST.fr
Retrouvez toute notre enquête sur le poids des laboratoires à l'hôpital public Abonnés.

Dans les CHU, ce que pès e l'argent des labos

SANTÉ En 2018, l'industrie a dépensé plus de 170 millions d'euros en direction des centres hospitaliers universitaires (CHU) français. Bordeaux apparaît dans le peloton de tête

TRANSPARENCE CHU
À l'initiative de « Sud Ouest », un collectif de journalistes, à travers toute la France, a épluché plusieurs millions de données, documentant de façon inédite les liens financiers entre l'industrie pharmaceutique et les CHU

Dossier réalisé par Marie Toulemonde, Frédéric Sallet et Yann Saint-Sernin avec Michel Bardy
general@sudouest.fr

Des repas. Des chambres d'hôtel. Des essais cliniques, des sessions de formation, des contrats d'orateur ou encore des études de marché… Les liens d'intérêts de l'industrie de la santé avec le monde médical sont légion. Selon nos calculs, plus de 170 millions d'euros ont, ainsi, irrigué les 32 centres hospitaliers universitaires (CHU) français et leurs personnels pour la seule année 2018. À tout le moins selon les déclarations des laboratoires transmises au ministère de la Santé, et que nous avons épluchées (lire par ailleurs). En y ajoutant les liens avec les associations domiciliées dans les CHU, la somme tutoie les 200 millions d'euros. Le double du déficit de ces trente-deux établissements cette même année…

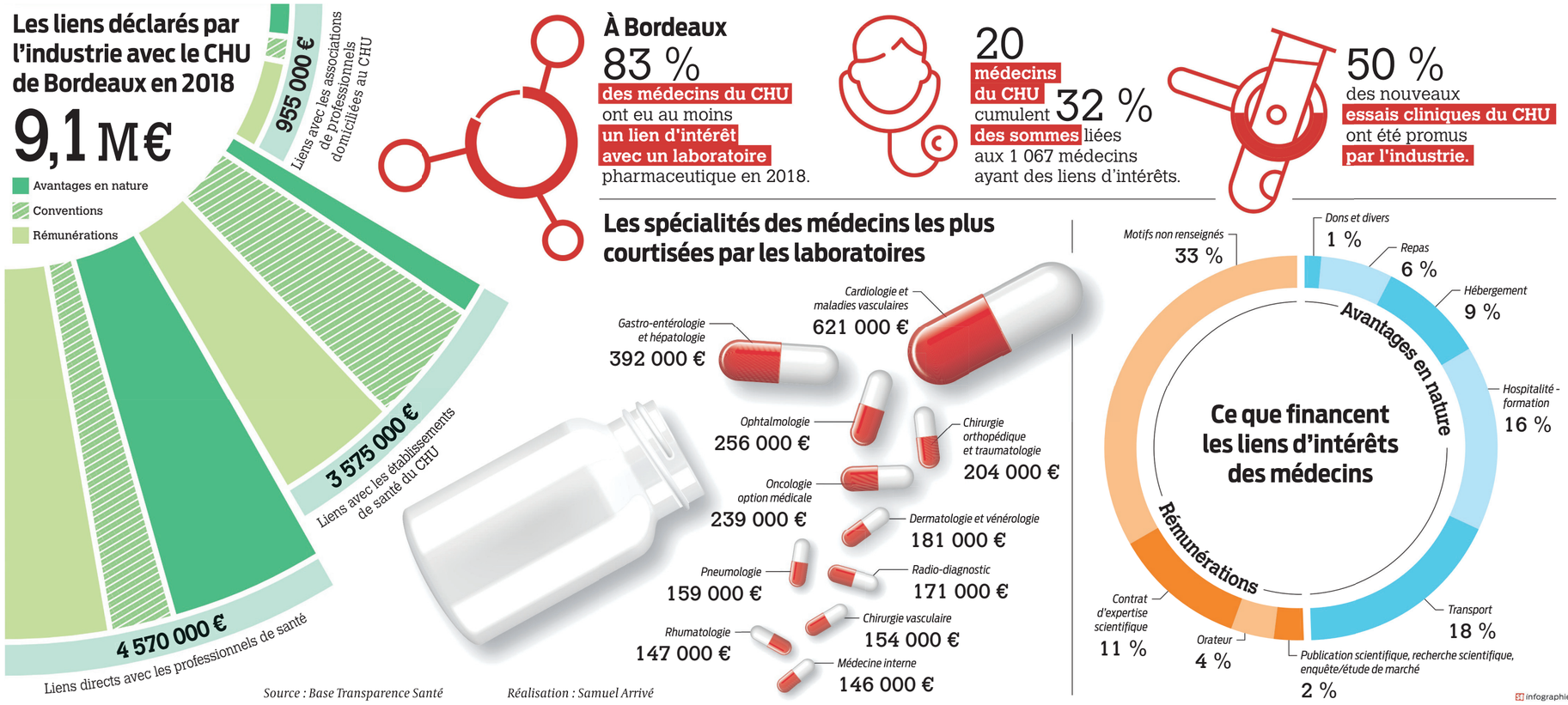
Si le scandale du Mediator en 2010 a déjà mis en lumière les conséquences sanitaires des conflits d'intérêts entre la sphère médicale et la sphère industrielle (bien que ces liens soient parfaitement légaux), l'implication des laboratoires dans l'hôpital public, notoirement sous-doté, est loin de s'être interrompue ces dernières années.

Congrès à Paris, Orlando…

En France, le CHU de Bordeaux est dans le trio de tête des plus gros « bénéficiaires », proportionnellement à la taille de son équipe. Il totalisait, en 2018, 9 millions d'euros de liens déclarés avec l'industrie pharmaceutique. Mais que comprennent ces liens ? Des milliers d'avantages en nature (sans contreparties) et autant de rémunérations liées à des conventions (contrats passés avec une société) que nous détaillons dans l'infographie ci-contre.

Sur la manne bordelaise, près de 3,5 millions sont reliés à des conventions passées entre les entreprises et le CHU, essentiellement pour l'indemnisation des essais cliniques réalisés à l'hôpital à la demande de l'industrie. Et 4,5 millions correspondent à des liens établis directement entre les médecins et les laboratoires pharmaceutiques. Sur 1 286 médecins rattachés au CHU de Bordeaux, 1 067 présentaient au moins un lien d'intérêt avec l'industrie déclaré par cette dernière. Des sommes auxquelles il faut ajouter plus de 900 000 euros dont ont bénéficié des associations de professionnels domiciliées au CHU.

Haut lieu de la recherche, de l'excellence scientifique et technologique, mais aussi de la formation des futurs médecins, rassemblant l'essentiel des leaders d'opinion, les hôpitaux publics sont très courtisés. L'industrie a, par exemple, offert 6 606 repas à 1 255 professionnels de santé de Pellegrin (essentiellement des médecins) en 2018. Elle s'est investie au moins 4 357 fois dans des participations à des congrès ou manifestations scientifiques – de Paris à Orlando (États-Unis) en passant par Venise et Singapour – déboursant pas moins d'1,2 million d'euros pour simplement transporter et loger des médecins. Des dépenses souvent justifiées par les besoins de formation continue des praticiens pour laquelle la puissance publique semble avoir largement laissé le champ libre à l'industrie. Pour la formation médicale, le CHU de Bordeaux assurait disposer en 2018 de 460 000 euros (lire en pages suivantes). À ce prix, difficile de résister aux sirènes financières des laboratoires…



« Ça, on ne le dit pas aux médecins »

Courroies de transmission entre laboratoires et médecins, les visiteurs médicaux opèrent à la charnière entre promotion et information

Tous les jours, Léa (1) jette un œil à ses résultats. Son employeur, un laboratoire pharmaceutique, organise régulièrement des concours. La visiteuse médicale, porte-parole de sa firme, a parfois décroché la timbale en pulvérisant des records de vente d'accessoires médicaux. À la clé : un voyage au bout du monde. « Ça, on ne le dit pas aux médecins, ils n'aiment pas le savoir », explique Léa. Elle ne cache pas qu'elle est un peu comme chez elle dans le centre hospitalier universitaire (CHU), de sa région (hors Nouvelle-Aquitaine), même si « c'est un peu plus encadré qu'avant. Je suis connue. Si j'ai trois rendez-vous officiels, la plupart du temps, je traîne dans les couloirs, juste pour être présente. Je salue les professeurs, je leur demande comment ils vont. Parfois, ils me parlent de leurs patients ou de ma molécule. »

Les hôpitaux publics sont des cibles de choix pour l'industrie. Un chiffre illustre cet investissement : si les CHU ne regroupent que 18 % des professionnels de santé en France, ils concentrent 38 % des sommes dépensées en promotion par les laboratoires. « C'est là que se situent les leaders d'opinion. Ils publient beaucoup d'études. La force de prescription est énorme et elle est suivie en ville », confirme la visiteuse médicale dont l'activité consiste aussi à informer scientifiquement les spécialistes des forces et faiblesses des molécules au catalogue de son employeur.

Fini les grands gueuletons

Sur son portable, Léa nous présente un tableau informatisé. Les médecins y sont classés nominativement en fonction de leurs capacités de prescription : « very high », « high », « medium », « low »… En face de chacun, une colonne avec les objectifs fixés à Léa. « Chaque visite est renseignée avec des items à cocher pour mentionner les messages délivrés. »

« En ce moment, c'est la guerre des biosimilaires (2) », relève Léa. Elle se désespère. « On n'a plus de congrès à offrir. Alors on se démerde, on organise des réunions, on déjeune avec des professeurs… » D'après la loi, les déjeuners ne doivent pas être prévus et naître d'une « opportunité ». « Ça veut dire que je croise un médecin dans le couloir, je lui propose un déj' et il me répond : "Volontiers !" Bon, dans la réalité, je lui envoie un message avant… » Idem pour les rendez-vous : « Si l'objectif est de voir 19 fois un médecin dans l'année, il y a seulement trois rendez-vous pris officiellement ».

Stéphane (1), spécialisé dans le matériel médical et qui rayonne dans le Sud-Ouest, assure pour sa part ne plus inviter les médecins à déjeuner. « Je préfère passer par le personnel biomédical, il n'y a pas d'obligation de le déclarer et c'est lui qui nous tient au courant des achats de matériel à venir. » Quant aux invitations des professionnels à des congrès, pour lui aussi, elles se réduisent faute de budgets.

Les visiteurs médicaux notent que leur métier a changé. SHUTTERSTOCK

La loi a changé le métier de Léa et Stéphane, qui reconnaissent que les gueuletons où le laboratoire rinçait toute la famille d'un médecin ne sont plus d'actualité. Et leurs employeurs multiplient les alertes. « Mon labo veut laver plus blanc que blanc. Ça nous pénalise car les autres ne se gênent pas. Heureusement, beaucoup de choses se font à l'oral et ça, on n'est pas obligé de le déclarer. »

(1) Le prénom a été changé
(2) Des médicaments interchangeables avec d'autres équivalents dont ils partagent les qualités et les effets indésirables.

Prescriptions sous influence ?

Des études pointent des corrélations entre liens d'intérêts et coût des prescriptions

Les liens d'intérêts des médecins avec les laboratoires influent-ils sur les prescriptions ? « Il faut être paranoïaque pour penser qu'un médecin va prescrire un mauvais médicament à son patient parce qu'un labo lui aura payé un voyage à un congrès », pense le professeur Nicholas Moore, directeur de la plateforme Bordeaux PharmacoEpi, qui réalise des études sur les médicaments en conditions réelles d'utilisation. Sans évacuer l'idée qu'« à molécules égales, un médecin sera peut-être tenté d'utiliser celle d'un labo qu'il connaît bien ».

« On ne parle pas ici de corruption, mais d'influence. La corruption est consciente, l'influence est inodore et involontaire, c'est justement le danger », explique le professeur Marco Romero, à l'origine d'une formation sur les méthodes marketing de l'industrie pharmaceutique (Facripp) dispensée à la faculté de médecine de Bordeaux. Coordonnée par le médecin rennais Bruno Goupil, une étude a récemment mis en regard les liens d'intérêts des médecins généralistes français et les conséquences sur leurs prescriptions. Elle a relevé que ceux ayant des liens d'intérêts prescrivaient en moyenne des médicaments avec de moindres indicateurs d'efficacité et plus chers que les praticiens n'ayant pas de liens. Ce que valident d'autres études anglo-saxonnes parues fin 2019.

« Difficile à démontrer »

« Nous sommes peu exposés sur ce point car nos médicaments sont achetés en groupe », assure Philippe Morlat, président de la Commission du médicament du CHU de Bordeaux. Pour autant, les médicaments à disposition de l'hôpital laissent une marge de manœuvre. « L'influence est très difficile à démontrer car beaucoup de facteurs interviennent dans une prescription », poursuit Marco Romero. Par exemple, selon des documents internes consultés par « Sud Ouest », au sein d'un même service d'un CHU français, pendant quatre ans, deux unités ont eu une utilisation radicalement différente d'un même médicament coûteux et n'apportant aucune amélioration par rapport aux autres traitements, selon la Haute Autorité de la santé. La première unité en utilisait 15 015 euros par an et par lit. La seconde, 1 691 euros, soit dix fois moins, préférant visiblement utiliser les traitements classiques, moins chers. La première unité totalisait sur la même période 11 000 euros de liens d'intérêts avec le laboratoire vendant la molécule. La seconde… dix fois moins également ! Mais au sein de la première unité, un médecin menait par ailleurs des recherches sur la maladie pour laquelle ce médicament est indiqué. Faut-il voir l'effet d'un médecin devenu leader d'opinion au sein de son unité en raison d'une connaissance pointue sur un médicament ? Une expertise acquise à tout le moins grâce au même laboratoire qui avait, par ailleurs, largement financé ses recherches…

Aux sources de notre enquête

Le dossier à l'initiative de « Sud Ouest » que nous publions avec une dizaine de titres de la presse quotidienne régionale est le fruit du collectif "Data + Local", un réseau de journalistes de données. Depuis novembre, nos rédactions ont travaillé de concert pour décrypter les liens d'intérêts entretenus par les professionnels de santé des 32 CHU français avec l'industrie, en 2018. Tous les liens d'intérêts sont légaux et ne sont évidemment pas condamnables a priori.

Nous avons pu nous appuyer sur les données publiques de la base Transparence santé (transparence.sante.gouv.fr) mises à disposition par le ministère des Solidarités et de la Santé. Notre travail a été facilité par le projet Eurosfordocs (eurosfordocs.fr). Transparence santé a vocation à rendre visibles les liens financiers entre les médecins et les entreprises de la santé dès lors que leur montant dépasse 10 euros. Les entreprises sont tenues d'y déclarer les conventions signées avec les professionnels de santé dans le cadre de leur fonction. Les liens d'intérêts avec les établissements publics ou privés, avec les associations de professionnels ou de patients y sont également recensés. Toutefois, la base connaît des limites. Les données sont auto-déclarées par les entreprises de la santé, sans contrôle a posteriori de leur conformité.

Pour analyser plus spécifiquement les relations de l'industrie avec l'hôpital public, nous avons croisé les données de la base Transparence avec celles de l'Annuaire santé (annuaire.sante.fr). Dans un second temps, nous avons également corrigé manuellement la situation de médecins apparaissant dans la base Transparence santé pour lesquels aucun identifiant n'était renseigné. Mais plusieurs milliers de déclarations n'ont finalement pu être exploitées en raison des erreurs de saisie ou des omissions qu'elles comportaient, entraînant une sous-estimation probable des montants que nous publions aujourd'hui. Retrouvez la méthodologie détaillée sur sudouest.fr.